

INFECCIÓN URINARIA EN GESTANTE

María Otero Pardo, A. Martín Sanz.

INTRODUCCIÓN

Las infecciones del tracto urinario son una de las complicaciones médicas más frecuentes durante la gestación. Su incidencia se estima en un 5-10% de todos los embarazos, siendo la causa de hasta un 10% de los ingresos hospitalarios en gestantes.

Se considera infección del tracto urinario (ITU) la presencia en un cultivo de orina de una bacteriuria significativa (>100.000 UFC/ml de un único patógeno) en orina recogida por micción espontánea, o >1.000 UFC/ml si se recoge por sondaje vesical, o cualquier cantidad si la muestra se obtiene mediante punción suprapúbica.

Existen una serie de factores de riesgo como:

- Bacteriuria asintomática.
- Historia de ITUs de repetición.
- Litiasis renal.
- Malformaciones uroginecológicas.
- Diabetes mellitus.
- Enfermedades neurológicas (vejiga neurógena, vaciado incompleto...)
- Anemia de células falciformes.
- Infección por *Chlamydia trachomatis*.
- Multiparidad.
- Nivel socioeconómico bajo.

ETIOLOGÍA

Los microorganismos más frecuentemente implicados son:

- Bacilos gram negativos: *Escherichia coli* (80-90% de los casos), *Klebsiella pneumoniae* o *Proteus mirabilis*.
- Cocos gram positivos: *Streptococcus agalactiae*, *Enterococcus spp* o *Staphylococcus saprophyticus*.

TIPOS DE INFECCIONES DE VÍAS URINARIAS

Bacteriuria asintomática

Introducción

Es la presencia de bacterias en la orina de la embarazada en ausencia de síntomas clínicos. Aparece en un 2-10% de los casos y la mayoría de las veces se da en el primer trimestre de la gestación.

El principal riesgo radica en que hasta un 25-30% pueden desarrollar una pielonefritis aguda en el caso de no ser tratadas. Ésta a su vez conlleva un mayor riesgo de parto pretérmino y bajo peso al nacimiento, aumentando así la morbi-mortalidad perinatal, de ahí la importancia del cribado gestacional de esta patología en el primer trimestre de embarazo.

Diagnóstico

Es microbiológico: urocultivo con >100.000 UFC/ml de un único patógeno, en una paciente sin

clínica urinaria. Un recuento entre 10.000 y 100.000 UFC o cultivos polimicrobianos indican contaminación.

Para el diagnóstico NO son válidos ni el estudio microscópico de la orina, ni las tiras reactivas, pues la mayoría de las bacteriurias asintomáticas cursan sin leucocituria.

Tratamiento

	1ª Elección	Alergia betalactámicos
Empírico	- Fosfomicina trometamol 3g vo (dosis única) - Cefuroxima 250 mg/12h vo 5-7días	- Fosfomicina trometamol 3g vo (dosis única)
Si antibiograma disponible (usar el de menor espectro)	- Fosfomicina trometamol 3g vo (dosis única) - Amoxicilina 500 mg/8h vo 5-7días - Cefuroxima 250 mg/12h vo 5-7días - Amoxicilina-clavulánico* 500 mg/8h 5-7días	- Fosfomicina trometamol 3g vo (dosis única) - Nitrofurantoína 50-100 mg/6h vo 5-7días

Tratamiento de la bacteriuria asintomática

Cistitis aguda

Introducción

Es un síndrome caracterizado por clínica miccional de aparición repentina: disuria, polaquiuria, tenesmo vesical y dolor suprapúbico y uretral durante o tras la micción, en ausencia de síntomas de afectación sistémica. Tiene lugar en un 1.5% de las gestaciones y con más frecuencia en el segundo trimestre.

La orina suele ser de aspecto turbio (presencia de leucocitos) y con poso purulento (leucocitos en gran cantidad o piuria). La hematuria microscópica aparece hasta en un 60% de los casos, y en fases agudas puede ser macroscópica.

Diagnóstico

Síndrome miccional y pruebas complementarias:

- Sedimento y sistemático de orina con leucocituria (>10leucos/ml en cámara o >3-5leucos/campo de 40 aumentos), presencia o no de proteínas y hematíes.
- Urocultivo con >1000UFC/ml en mujeres sintomáticas + antibiograma.

Hasta en un 50% de mujeres con clínica de cistitis, el urocultivo es negativo, estos casos se denominan síndrome uretral agudo o cistitis abacteriúrica y están asociados en muchas ocasiones a Chlamydias. Su diagnóstico precisa métodos especiales de cultivo o técnicas de amplificación genética (PCR). Este cuadro responde al tratamiento con eritromicina.

Tratamiento

	1ª Elección	Alergia betalactámicos
Empírico	- Fosfomicina trometamol 3g vo (dosis única) - Cefuroxima 250 mg/12h vo 5-7días	- Fosfomicina trometamol 3g vo (dosis única)

	1ª Elección	Alergia betalactámicos
Si antibiograma disponible (usar el de menor espectro)	-Fosfomicina trometamol 3g vo (dosis única) -Amoxicilina 500 mg/8h vo 5-7días -Cefuroxima 250 mg/12h vo 5-7días -Amoxicilina-clavulánico* 500 mg/8h 5-7días	-Fosfomicina trometamol 3g vo (dosis única) -Nitrofurantoína 50-100 mg/6h vo 5-7días

* El clavulánico estaría contraindicado antes de la semana 34 de gestación por el mayor riesgo de enterocolitis necrotizante en el recién nacido.

Tratamiento de la bacteriuria asintomática y de la cistitis

Independientemente de la pauta terapéutica empleada, existen recurrencias hasta en un 20-30% de los casos, por lo que se aconseja realizar un urocultivo de control 1-2 semanas después de finalizado el tratamiento.

El tratamiento antibiótico supresor puede ser adecuado en gestantes con bacteriuria asintomática que persiste tras dos o más ciclos de un tratamiento adecuado. Se mantendrá toda la gestación y hasta 4-6 semanas postparto. Los fármacos recomendados son Fosfomicina trometamol 3 g 1 sobre/semana o Cefalexina 250 mg/24h vo.

Puede realizarse en pauta continua o bien en pauta postcoital en aquellas mujeres con historia sugestiva de ITU relacionadas con la actividad sexual, en cuyo caso se administra una dosis de antibiótico en las 2 horas siguientes al coito.

Pielonefritis aguda

Introducción

Es una infección de la vía excretora alta y del parénquima renal que aparece en el 1-2% de las gestaciones. El 80-90% se dan en el segundo-tercer trimestre de embarazo y en el puerperio. Suele ser secundaria a una bacteriuria asintomática no diagnosticada o mal tratada.

Cursa con afectación del estado general, fiebre $>38^{\circ}\text{C}$, náuseas, vómitos y dolor costovertebral con puñopercusión lumbar positiva. La localización más frecuente es el lado derecho, debido a la dextrorrotación uterina. NO suele presentar clínica de síndrome miccional.

Diagnóstico

Clínica sugestiva y pruebas complementarias:

- Hemograma (leucocitosis con desviación izquierda).
- Bioquímica con glucosa, urea, creatinina, sodio, potasio, cloro, PCR / Procalcitonina.
- Sedimento y sistemático de orina (leucocituria, cilindros leucocitarios, proteinuria y hematíes).
- Urocultivo positivo + antibiograma.
- Hemocultivo.
- Ecografía renal si sospecha de litiasis renal o afectación sistémica grave.

Tratamiento

Es importante realizar una valoración obstétrica de estas pacientes para comprobar el estado fetal, así como una evaluación del balance hídrico; en este sentido se debe llevar a cabo una correcta hidratación intravenosa para conseguir diuresis >30 ml/h.

Se debe iniciar inmediatamente el tratamiento antibiótico de forma empírica:

1ª Elección	Alergia betalactámicos
- Ceftriaxona 1 g/24 h iv 14 días - Amoxicilina/clavulánico 1 g/8h iv 14 días - Cefuroxima 750 mg/8h iv 14 días	- Gentamicina 80 mg/8 h iv - Aztreonam 1 g/8h iv 14 días - Fosfomicina 100 mg/Kg/día 14 días

Tratamiento de la pielonefritis aguda

Si la fiebre ha descendido a las 48-72 horas y se dispone de antibiograma se pasará a terapia oral con el antibiótico de menor espectro, y se mantendrá durante 14 días. Si no se dispone de antibiograma, se iniciará tratamiento empírico con cefuroxima 250 mg/12h vo, o en caso de sospecha de resistencias cefixima 400 mg/24 vo, ambos durante 14 días.

Se recomienda igualmente urocultivo de control en 1-2 semanas tras finalizar el tratamiento. El tratamiento supresor estaría indicado en casos de pielonefritis recidivante durante la gestación, o tras un único episodio en pacientes con patología renal o de vías excretoras (monorrena, trasplantada renal...)

BIBLIOGRAFÍA

- Infección urinaria y gestación. Protocolos Asistenciales en Obstetricia. Sociedad Española de Ginecología y Obstetricia. 2013.
- Urinary Tract Infections in Pregnancy. South Australian Perinatal Practice Guidelines. 2017.
- Nicolle LE. Management of asymptomatic bacteriuria in pregnant women. Lancet Infect Dis. 2015 Nov;15(11):1252-4. doi: 10.1016/S1473-3099(15)00145-0. Epub 2015 Aug
- Thomas M Hooton, Kalpana Gupta. Urinary tract infections and asymptomatic bacteriuria in pregnancy. [Monografía en Internet, Topic 8065 Version 51.0]. Waltham (MA): UpToDate® [acceso 10 de Noviembre de 2018]. Disponible en: <http://www.uptodate.com/>